Hjelp! Petter må bestå helsefag eksamen!!

Han trenger ekstra cash til en skikkelig klokke!!

HEA3103 Høst 2024

Oppgave 1 ca. 50 %, oppgave 2 ca. 50 %

Case / situasjon

Sted: Hjemmesykepleien (morgen og kveld)

Pasient: Eva Larsen, f. 19.02.1939, enke. To døtre. Adresse Dalen.

Bakgrunn: Ny pasient. Hjem etter korttidsopphold på sykehjem pga. urinveisinfeksjon, forvirring og flere fall. Pårørende bekymret for hygiene og lite mat/drikke. Eva liker ikke hjelp og vil klare seg selv.

Diagnoser: Tilbakevendende/hyppig urinveisinfeksjon.

Fra pasientjournal:

- Hygiene: vil klare selv; pårørende bekymret for kroppslukt, ønsker veiledning.
- Ernæring: underernært, lite motivert for matlaging, 1–2 glass vin daglig.
- Psykososialt: lange dager, ensom, lite nettverk, regelmessig besøk av døtrene.
- Fysisk: beveger seg normalt, men kan være ustødig. Trygghetsalarm.
- Samarbeid: fastlege, ergoterapeut, hjemmehjelp hver 3. uke.
- Kommunikasjon: liker å prate.

Oppgaver og eksempelsvar

Oppgave 1

Oppgavetekst: Eva liker ikke å ta imot hjelp fra hjemmesykepleien og er bestemt på å klare seg selv. Beskriv hvordan du går fram for å gi Eva nødvendig helsehjelp. Begrunn svaret. Viktige momenter: pasient- og brukermedvirkning, kommunikasjon og samhandling.

Eksempelsvar

Innledning

Eva Larsen er ny pasient i hjemmesykepleien. Hun har vært på korttidsopphold på sykehjem etter urinveisinfeksjon, forvirring og flere fall, og hun har tilbakevendende urinveisinfeksjoner. Døtrene er bekymret for hygienen og for at hun spiser og drikker lite. Eva liker ikke hjelp og vil klare seg selv. Oppgaven min er å gi henne nødvendig helsehjelp på en måte som respekterer at hun vil bestemme selv, samtidig som jeg tar risikoen på alvor.

Hoveddel

Det første jeg gjør, er å bygge en relasjon. Jeg ringer på, presenterer meg og forklarer hvorfor jeg kommer. Jeg spør om jeg kan komme inn, fordi jeg er gjest i hjemmet hennes. Eva liker å prate, og det bruker jeg. Jeg lar henne fortelle om livet sitt og hvordan dagene er. Jeg lytter aktivt og viser at jeg forstår at det er viktig for henne å klare seg selv. Når hun føler seg hørt, er det lettere for henne å stole på meg.

Deretter forklarer jeg ærlig og enkelt hvorfor hjemmesykepleien kommer. Jeg kan si at hun har vært gjennom en tøff tid med infeksjon og fall, og at målet er at hun skal klare seg trygt hjemme lengst mulig. Jeg unngår å skremme henne eller snakke ned til henne. Jeg legger vekt på at hjelpen skal støtte det hun klarer selv, ikke ta over.

Så tilbyr jeg hjelp i små steg og gir henne reelle valg. Kanskje er det lettere for henne å si ja til at vi drikker en kopp kaffe og spiser litt sammen enn til hjelp med dusjen. Jeg spør hva hun synes er vanskelig, og hva hun ønsker hjelp til. Pasient- og brukerrettighetsloven gir Eva rett til å medvirke og til å takke nei til helsehjelp når hun er samtykkekompetent. Hvis hun er forvirret, kan samtykkekompetansen svinge, og da må jeg melde det til sykepleier. Det er ikke min oppgave å vurdere samtykkekompetanse alene.

Underveis observerer jeg diskré. Jeg ser etter om hun er forvirret, om hun er ustødig, om det er lukt som kan tyde på urinlekkasje, og om det finnes mat i kjøleskapet. Ny forvirring kan være tegn på en ny urinveisinfeksjon. Dette dokumenterer jeg og melder til sykepleier.

Døtrene er viktige for Eva og besøker henne ofte. Jeg spør Eva om hun vil at de skal få informasjon og være med i samarbeidet. Uten samtykke har jeg taushetsplikt etter helsepersonelloven. Med samtykke kan døtrene bli en støtte, for eksempel ved å spise sammen med henne når de er på besøk. Jeg samhandler også med sykepleier, fastlege, ergoterapeut og hjemmehjelpen, slik at alle gir like råd og ikke overkjører Eva.

Jeg velger denne framgangsmåten fordi press og tvang kan gjøre at Eva sier nei til all hjelp. Da blir risikoen for nye fall, infeksjoner og underernæring større. Tillit er derfor en forutsetning for å gi forsvarlig helsehjelp.

Avslutning

For å hjelpe Eva går jeg veien om relasjon, ærlig kommunikasjon og medvirkning. Jeg respekterer at hun vil klare seg selv, observerer tegn på risiko og samarbeider med døtrene og andre fagfolk når hun samtykker. Slik øker sjansen for at hun etter hvert tar imot den hjelpen hun trenger.

Oppgave 2

Oppgavetekst: Ut fra tiltakene du har beskrevet i oppgave 1, bestemmer Eva seg for å ta imot hjelp. Skriv en tiltaksplan for Eva der du beskriver hva du vil gjøre, hvordan du vil gjøre det, og hvorfor du vil gjøre det slik.

Eksempelsvar

Innledning

Eva har nå sagt ja til hjelp fra hjemmesykepleien morgen og kveld. Hun har tilbakevendende urinveisinfeksjoner, er underernært, drikker 1–2 glass vin daglig, kan være ustødig og har falt flere ganger. Hun er ensom og har lange dager, men liker å prate og får besøk av døtrene. Målet med tiltaksplanen er at Eva skal få hjelp til hygiene,

mat og drikke og fallforebygging, slik at risikoen for ny infeksjon, fall og vekttap blir mindre, samtidig som hun beholder verdighet og mestring.

Hoveddel

Om morgenen veileder jeg Eva i personlig hygiene. Jeg lar henne gjøre det hun klarer, og jeg er der for å støtte, ikke for å ta over. Jeg sørger for god belysning, sklimatte og at hun kan sitte på en stol i dusjen hvis hun er ustødig. Jeg gir diskré råd om intimhygiene, for eksempel å vaske og tørke forfra og bakover og skifte undertøy daglig. Det er viktig for å forebygge urinveisinfeksjon. Jeg observerer huden og ser etter tegn på urinlekkasje. Fordi døtrene har vært bekymret for lukt, er det viktig at dette gjøres på en måte som ikke krenker Eva.

Når det gjelder mat og drikke, spør jeg Eva hva hun liker, og vi lager frokost sammen. Jeg tilbyr små og næringsrike måltider, for eksempel egg, ost, yoghurt og grovbrød med godt pålegg. Jeg setter fram drikke og oppfordrer henne til å drikke jevnt gjennom dagen. Nok væske skyller urinveiene og reduserer faren for ny infeksjon. Om kvelden kan jeg sette fram et lite kveldsmåltid. Jeg snakker forsiktig med henne om vinen og forklarer at alkohol kan øke faren for fall og gi mindre matlyst. Jeg moraliserer ikke, men gir henne kunnskap til å velge selv. Hvis hun fortsetter å gå ned i vekt, melder jeg det til sykepleier, som kan vurdere næringsdrikk sammen med fastlegen. Jeg kan også følge med på vekten etter avtale.

For å forebygge fall ser jeg sammen med Eva på hjemmet. Vi ser etter løse tepper, ledninger og dårlig lys, og jeg sjekker at hun har gode sko. Jeg minner henne på å ha trygghetsalarmen på seg. Hvis det trengs hjelpemidler, melder jeg til sykepleier, som kan kontakte ergoterapeuten.

Underveis observerer jeg tegn på urinveisinfeksjon, som svie, hyppig vannlating, feber eller at hun blir forvirret. Hos eldre kan forvirring være det første tegnet, slik det var hos Eva før. Jeg melder slike tegn til sykepleier med en gang.

Eva er ensom, så jeg tar meg tid til å prate under besøkene. Hvis hun ønsker det, kan vi snakke om aktiviteter eller frivillige tilbud, og med hennes samtykke kan døtrene være med å spise sammen med henne når de er der. Sosial kontakt kan gi bedre matlyst og livsglede.

Alt dokumenterer jeg i journalen. Jeg evaluerer etter noen uker sammen med sykepleier: Spiser og drikker Eva mer, holder vekten seg, har hun unngått nye fall og infeksjoner, og føler hun at hjelpen respekterer henne?

Avslutning

Tiltaksplanen bygger på tilliten fra første møte og på det journalen sier om Eva. Hun får hjelp til hygiene, ernæring og fallforebygging, samtidig som hun får bestemme og gjøre mest mulig selv. Jeg observerer og rapporterer endringer, og samarbeider med sykepleier, fastlege, ergoterapeut og døtrene.

Eksempelsvar til øving, skrevet med sikte på et nivå mellom karakter 4 og 5. Uoffisielt – ikke en karaktergaranti eller offisielt fasitsvar.